



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

PEDOMAN PELAYANAN UNIT STERILISASI

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor 571.5/I-PDM/DIR/VI/2025

Tentang
Pedoman Pelayanan Unit Sterilisasi

Disusun oleh :
Penanggung Jawab Unit Sterilisasi



(Ahmad Taufan Fauzi, A.Md.Kep)

Disetujui oleh :
Authorized Person



(Dr. dr. Aslichah, M. Kes. AFP)

Ditetapkan oleh :

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



(dr. Nur Mazidah)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karuniaNya, tim penyusun dapat menyelesaikan pedoman pelayanan unit sterilisasi Rumah Sakit Prima Husada.

Pedoman Pelayanan unit sterilisasi RS Prima Husada Tahun 2025 ini yang mulai dipergunakan pada tahun 2025 meliputi kegiatan pelayanan yang dilakukan di unit sterilisasi Rumah Sakit Prima Husada.

Kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi di dalam penyusunan pedoman ini. Kami mengharapkan segala saran, kritik dan masukan yang membangun untuk memperbaiki isi dari buku pedoman ini.

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Nur Mazidah

TIM PENYUSUN

PEDOMAN PELAYANAN UNIT STERILISASI

1. dr. Nur Mazidah
2. dr. Aida Musyarofah, Sp. OG
3. Sherly Rosita, S.Kep., Ns
4. Putri Indah P, A.Md.Keb
5. Tri Ani Darma, A.Md.Kep
6. Laras Wieny Nuriska, A.Md.Kep
7. Ahmad Taufan Fauzi, A.Md.Kep
8. Safitri Retno K, A.Md.Kep
9. Lola Novira R, A.Md.Kep
10. Ahmad pristiwanto
11. Davit Krisdianto

DAFTAR ISI

JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN ii

KATA PENGANTAR..... iii

TIM PENYUSUN iv

DAFTAR ISI v

DAFTAR GAMBAR vi

DAFTAR TABELvii

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADAviii

LAMPIRAN..... 1

BAB I..... 1

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang..... 1

1.2 Tujuan Pedoman..... 1

1.3 Ruang Lingkup Pelayanan 1

1.4 Batasan Operasional..... 1

BAB II..... 3

STANDAR KETENAGAAN 3

2.1 Kualifikasi Sumber Daya manusia 3

2.2 Distribusi Ketenagaan 3

2.3 Pengaturan Jaga..... 3

BAB III..... 4

STANDAR FASILITAS 4

3.1 Denah Ruang..... 4

3.2 Standar Fasilitas 4

3.3 Pemeliharaan Peralatan 5

BAB IV 7

TATA LAKSANA PELAYANAN 7

4.1 Tata Laksana Pelayanan Dekontaminasi 7

4.2 Tata laksana pelayanananan Proses Sterilisasi : 9

BAB V 11

LOGISTIK 11

BAB VI 12

KESELAMATAN PASIEN DAN PETUGAS..... 12

BAB VII 13

KESELAMATAN KERJA 13

BAB VIII 16

PENGENDALIAN MUTU 16

BAB IX 19

PENUTUP 19

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Denah Ruang

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Distribusi Ketenagaan
Tabel 2.2	Pengaturan Jaga
Tabel 4.1	Bahan Pengemas
Tabel 4.2	Linen Steril Pada Kegiatan Bedah
Tabel 4.3	Peralatan Single Use yang Di Reuse
Tabel 5.1	Peralatan CSSD
Tabel 7.1	Standar Bangunan
Tabel 8.1	Batas Kadaluarsa Produk Hasil Steril



**PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR : 571.5/I-PDM/DIR/VI/2025**

TENTANG

PEDOMAN PELAYANAN UNIT STERILISASI

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Prima Husada, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan yang bermutu tinggi dari setiap instalasi pelayanan yang ada;
- b. bahwa agar pelayanan pencegahan dan pengendalian infeksi dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya Peraturan Direktur tentang kebijakan pemberlakuan buku Pedoman Pelayanan CSSD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b perlu ditetapkan dengan Peraturan Direktur Rumah sakit Prima Husada;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di Fasilitas Kesehatan;
4. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/413/2020 tentang Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standart Akreditasi Rumah Sakit;
7. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
8. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor: 263/DPM/I-KEP/DIR/I/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang;
9. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 390/I-KEP/DIR/V/2023 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN UNIT STERILISASI
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA.**



Pasal 1

- (1) Pencegahan dan Pengendalian Infeksi yang selanjutnya disingkat PPI adalah upaya untuk mencegah dan meminimalkan terjadinya infeksi pada pasien, petugas, pengunjung, dan masyarakat sekitar fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Rumah sakit menetapkan organisasi pencegahan dan pengendalian infeksi sesuai dengan peraturan perundang – undangan.
- (3) Komite PPI menetapkan angka infeksi yang diukur.

Pasal 2

Perbersihan alat kesehatan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan meliputi kritikal, semi kritikal dan non kritikal.

Pasal 3

Rumah sakit menetapkan kebijakan bahwa tidak ada barang *single use* yang di *re use*.

Pasal 4

Rumah sakit tidak melakukan pelayanan CSSD diluar unit CSSD.

Pasal 5

Rumah sakit menetapkan pelayanan sterilisasi dengan teknik sterilisasi seperti instrument operasi, rawat luka, persalinan dan curettage; teknik DTT seperti alat NGT, jacksonrees; teknik desinfeksi tingkat rendah seperti tensimeter, thermometer.

Pasal 6

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang

Pada tanggal 4 Juni 2025

Direktur Rumah Sakit Prima Husada,

dr. Nur Mazidah

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH
SAKITPRIMA HUSADA
NOMOR 571.5/I-PDM/DIR/VI/2025
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN
UNIT STERILISASI

PEDOMAN PELAYANAN UNIT STERILISASI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah sakit sebagai institusi penyedia pelayanan kesehatan berupaya untuk mencegah risiko terjadinya infeksi bagi pasien dan petugas rumah sakit. Salah satu indikator keberhasilan dalam pelayanan rumah sakit adalah rendahnya angka infeksi nosokomial di rumah sakit. Untuk mencapai keberhasilan tersebut maka perlu dilakukan pengendalian infeksi di rumah sakit.

Instalasi pusat sterilisasi merupakan salah satu mata rantai yang penting untuk mengendalikan infeksi dan berperan dalam upaya menekan kejadian infeksi. Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, pusat sterilisasi sangat bergantung pada unit penunjang lainnya yang ada di rumah sakit. Apabila terjadi hambatan pada salah satu unit tersebut maka pada akhirnya akan mengganggu proses dan hasil sterilisasi.

Bila ditinjau dari volume alat dan bahan yang harus disterilkan di rumah sakit sedemikian besar, maka rumah sakit dianjurkan untuk mempunyai suatu instalasi pusat sterilisasi tersendiri dan mandiri. Instalasi pusat sterilisasi bertugas untuk memberikan pelayanan terhadap semua kebutuhan kondisi steril atau bebas dari semua mikroorganisme termasuk endospora secara tepat dan cepat.

1.2 Tujuan Pedoman

Tujuan pedoman ini dibuat sebagai acuan/ standar bagi Instalasi Pusat Sterilisasi dalam memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya untuk melayani dan membantu semua instalasi/unit di rumah sakit yang membutuhkan barang dan alat medis dalam kondisi steril.

1.3 Ruang Lingkup Pelayanan

Di CSSD RS. Prima Husada saat ini hanya melayani kebutuhan sterilisasi dilingkungan RS. Prima Husada yang meliputi rawat inap, rawat jalan, kamar bedah dan IGD.

1.4 Batasan Operasional

Central Sterile Supply Department (CSSD) adalah suatu unit di rumah sakit yang bertanggung jawab menyelenggarakan pelayanan sterilisasi untuk memenuhi kebutuhan akan barang/alat steril di seluruh unit rumah sakit.

Steril adalah suatu keadaan yang bebas dari mikroorganisme baik patogen maupun apatogen beserta spora.

Sterilisasi adalah suatu proses pengolahan alat atau bahan yang bertujuan untuk menghancurkan semua bentuk kehidupan mikroorganisme termasuk endospora melalui proses fisika maupun kimia.

Disinfeksi adalah suatu tindakan untuk membebaskan / menghancurkan, membunuh mikroorganisme baik patogen maupun apatogentetapi tidak dengan sporanya.

Dekontaminasi adalah proses kimia/fisika yang digunakan untuk menurunkan jumlah mikroorganisme pada benda mati sehingga aman untuk digunakan lebih lanjut. Yang dimaksud dengan pelayanan sterilisasi adalah kegiatan yang memproses semua bahan, peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan untuk pelayanan medik di rumah sakit, mulai dari perencanaan, pengadaan, pencucian, pengemasan, pemberian tanda, proses sterilisasi, penyimpanan dan penyalurannya untuk memenuhi kebutuhan rumah sakit. Pelayanan sterilisasi merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dengan kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit, khususnya dalam usaha menghindari infeksi silang, sehingga infeksi nosokomial dapat dicegah dan dikendalikan. Agar pelayanan sterilisasi dapat berjalan dengan baik sesuai standar dengan Mutu terjamin maka pelayanan sterilisasi dilakukan di instalasi pusat sterilisasi (CSSD).

BAB II

STANDAR KETENAGAAN

2.1 Kualifikasi Sumber Daya manusia

Kualifikasi tenaga yang bekerja di CSSD RS. Prima Husada dibedakan sesuai dengan kapasitas tugas dan tanggung jawabnya, yang dibagi atas koordinator dan pelaksana sterilisasi.

- Koordinator CSSD:
- 1. Minimal lulusan D3 Keperawatan
 - 2. Memiliki STR
 - 3. Mempunyai surat izin kerja
 - 4. Pelatihan & Pendidikan CSSD

- Pelaksana CSSD:
- 1. Lulusan sederajat
 - 2. Pelatihan & Pendidikan dasar CSSD

2.2 Distribusi Ketenagaan

Dinas Pagi	Perawat	1	Penanggung jawab
			Inventaris Instrumen BedahProses Sterilisasi Dekontaminasi
	Pelaksana	2	Penerimaan s/d Distribusi alat bedah
			Kebersihan CSSD
Dinas Midlle	Pelaksana	1	Penerimaan s/d Distribusi alat bedah
			Kebersihan CSSD
Dinas Sore	Pelaksana	1	Penerimaan s/d Distribusi alat bedah
			Kebersihan CSSD

Tabel 2.1 Distribusi Ketenagaan

2.3 Pengaturan Jaga

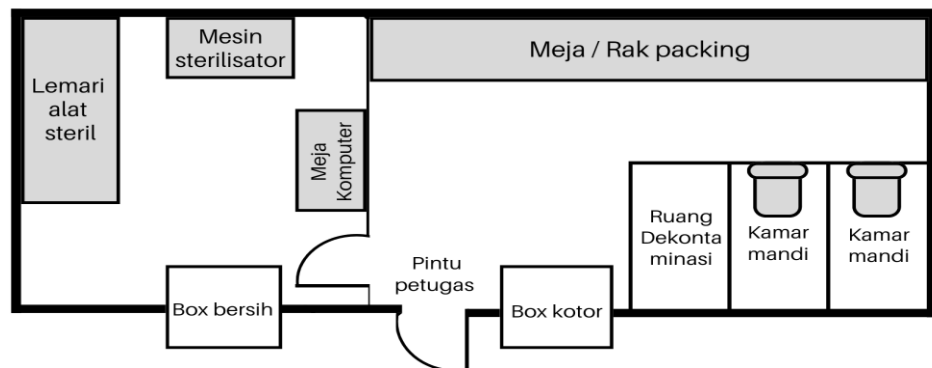
Jadwal Dinas	Waktu
Dinas Pagi	07.00 s/d 14.00
Dinas Midlle	10.00 s/d 18.00
Dines Sore	14.00 s/d 21.00

Tabel 2.2 Pengaturan Jaga

BAB III

STANDAR FASILITAS

3.1 Denah Ruang



Gambar 3.1 Denah Ruang

3.2 Standar Fasilitas

Pada prinsipnya ruangan CSSD terdiri dari daerah bersih, daerah kotor dan daerah Steril sehingga ruangan harus didesain sedemikian rupa sehingga tidak terjadi kontaminasi silang dari daerah kotor ke daerah bersih. Untuk menghindari kontaminasi silang.

1. Ruang dekontaminasi : Pada ruangan ini terjadi proses penerimaan barang kotor, dekontaminasi dan pembersihan /pencucian. Di daerah ini terdapat:
 - a. Loker penerimaan instrumen/alat lain
 - b. Beberapa bak untuk merendam dan mencuci
 - c. Handuk bersih untuk mengeringkan
 - d. Meja untuk melakukan pengeringan
2. Ruang pengemasan
Ruang ini untuk melakukan pengemasan terhadap barang /peralatan, linen.
3. Ruang Mesin
Tempat di mana proses sterilisasi dilakukan. Pada daerah ini terdapat: Sterilisator dry hit
4. Ruang Produksi bahan Steril
Tempat di mana pembuatan barang steril dilakukan.
5. Ruang Penyimpan Barang Steril
Terletak berdekatan dengan proses sterilisasi dilakukan. Ruang ini langsung berhubungan dengan pintu mesin sterilisasi. Ruang ini memuat:
 - Lemari dan rak menyimpan linen
 - Meja administrasiRuang ini bebas dari debu dan pintu selalu tertutup. Sirkulasi udara dipertahankan tetap baik dengan memasang fan / exhaust fan dan penerangan minimal kategori pencahayaan $D = 200-500$ Lux sesuai pedoman Pencahayaan Rumah Sakit, suhu $18-22^{\circ}\text{C}$ dan kelembaban $35-75\%$ RH.
6. Ruang Pendistribusian
Tempat di mana barang steril didistribusikan.

3.3 Pemeliharaan Peralatan

1. Pemeliharaan Sterilisator Secara Rutin dan Berkala

Mesin sterilisasi harus diperiksa dan dibersihkan setiap hari, karena pengawasan secara periodik dan pembersihan secara rutin dapat menurunkan kemungkinan tidak berfungsinya mesin sterilisasi. Kebersihan juga menurunkan risiko kontaminasi terhadap barang steril. Beberapa hal yang harus dibersihkan setiap hari meliputi:

- a. *Recording charts* dan jarum penunjuk
- b. Gasket pintu
- c. Bagian dalam *chamber* dan permukaan lainnya.

Pembersihan harian dan pengawasan lainnya sesuai dengan yang disarankan produsen mesin. Beberapa hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan pemeliharaan rutin sterilisator:

- a. Produsen mesin harus membuat instruksi tertulis untuk pemeliharaan mesin sterilisasi. Pemeliharaan ini harus dilakukan oleh orang yang ahli atau pihak IPSRS terkait. Perhatikan pemeliharaan dan penggantian komponen-komponen yang rusak.
- b. Pemeliharaan dapat dilakukan oleh petugas rumah sakit yang terlatih (IPSRS), produsen alat atau perusahaan pemberijasa pemeliharaan yang berkualifikasi.
- c. Untuk perbaikan rutin terhadap komponen umum dapat dilakukan oleh pihak rumah sakit setelah mendapat pelatihan dari supplier.
- d. Perbaikan terhadap komponen peralatan rutin hanya dilakukan oleh pihak yang mampu melakukannya. Teknisi yang terlibat dalam pemeliharaan peralatan harus dilatih oleh lembaga berwenang atau pihak pembuat mesin sterilisasi tersebut.

Beberapa hal yang harus diperhatikan sebagai upaya pemeliharaan dan pencegahan kerusakan:

- a. Garansi selama masa tertentu.
- b. Suku cadang pokok harus tersedia
- c. Sebaiknya dilakukan kontrak servis baik dengan pihak supplier atau pihak lain yang kompeten.
- d. Stabilisator voltase berikut saklar otomatis ke generator untuk keperluan darurat.
- e. Kondisi lingkungan, suhu dan kelembaban yang memadai.

2. Kalibrasi sterilisator

Kalibrasi terhadap mesin sterilisasi sangat penting dilakukan untuk menjamin bahwa mesin sterilisasi bekerja dengan baik dan efektif, serta dapat diandalkan. Kalibrasi secara periodik harus dilakukan sesuai instruksi manual produsen mesin, misal setahun sekali. Beberapa hal yang harus dikalibrasi meliputi pengukur suhu dan tekanan, timer, dan elemen pencatat lainnya. Kalibrasi ulang harus dilakukan bila komponen ini mengalami perbaikan. Kalibrasi harus dilakukan oleh orang yang terlatih khususnya terhadap jenis mesin yang akan dikalibrasi.

3. Pemeliharaan Ruang

Ruang dekontaminasi

- a. Usahakan lantai tidak basah/becek, bila basah harus segera dikeringkan. Ruang dan peralatan dibersihkan setiap hari: lantai, meja, alat-alat, dan wastafel menggunakan disinfektan.
- b. Memakai APD pada waktu membersihkan ruang dekontaminasi.

-
- c. Cuci tangan sebelum dan setelah membersihkan.
4. Ruang pengemasan, ruang ganti, kantor dan ruang staf
- a. Lantai, peralatan, meja, kursi, almari dibersihkan setiap hari sebelum dan setelah bekerja
 - b. Cuci tangan sesuai prosedur, siapkan semua peralatan yang diperlukan (kain pel, lap, ember, disinfektan) dan pakailah APD sebelum mulai pembersihan
 - c. Peralatan, meja, kursi dan almari dibersihkan dengan cara mengelap dengan lap yang dibasahi larutan sabun pH netral.
 - d. Lantai dibersihkan dengan cara mengepel dengan kain pel yang dicelupkan dalam larutan Creolin 1: 100
 - e. Setelah selesai mengelap maupun mengepel, lantai maupun peralatan dikeringkan dengan lap kering
 - f. Setelah kegiatan selesai, peralatan dicuci dan dikeringkan, simpan di tempat khusus dalam keadaan siap pakai.
 - g. Cucilah tangan kembali.
5. Pembersihan dan sterilisasi ruang steril
- a. Peralatan, almari dibersihkan dengan cara mengelap dengan lap yang dibasahi larutan Lysol 1:100 atau presept 2.5 gram : 2.5 liter air.
 - b. Lantai dibersihkan dengan cara mengepel dengan kain pel yang dicelupkan dalam larutan Creolin 1: 100 Semua peralatan yang digunakan harus disterilkan terlebih dahulu. Petugas harus mengenakan APD khusus ruang steril (baju, topi, masker, alas kaki khusus).

BAB IV

TATA LAKSANA PELAYANAN

4.1 Tata Laksana Pelayanan Dekontaminasi

1. Penanggung jawab
 - a. Petugas Dekontaminasi
 - b. Perawat Intrumen Bedah
2. Perangkat kerja
 - a. Peralatan Medis On Steril
 - b. Cairan Enzym, cairan Desinfektan, dan sikat instrument
 - c. APD (sepatu, sarung tangan, tutup kepala, masker, Skort dan kaca mata)
3. Tata laksana pelayanan
 - a. Penerimaan barang steril: jam 08.00 - 10.00
 - b. Penerimaan barang tidak steril: jam 09.00 - 11.00
 - c. Semua peralatan medis tidak steril ditulis dalam Buku Penerimaan peralatan tidak Steril (No. urut, jam pengantaran, bagian yang mengirim, jenis peralatan, jumlah, jenis kemasan, tanda tangan petugas ruang dan perugas CSSD)
 - d. RS Prima husada tidak menggunakan alat re-useable
 - e. Untuk peralatan yang kadaluarsa ditulis No.ID dan tanggal kadaluarsa.
 - f. *Pre-Cleaning*

Langkah pertama dalam proses dekontaminasi dimulai setelah peralatan, instrumen atau alat lainnya digunakan pada pasien dianggap terkontaminasi peralatan pakai ulang. Semua peralatan dibilas dibawah air mengalir. Peralatan medis On Steril harus ditransportasikan ke ruang dekontaminasi CSSD dalam container tertutup khusus peralatan On-steril.
 - g. Perendaman

Peralatan pakai ulang harus dikondisikan lembab atau basah untuk mencegah pengeringan materi organik pada peralatan tersebut dan untuk memperlunak materi organik tersebut sehingga memudahkan pada saat pembersihan. Cairan untuk merendam alat berupa larutan enzimatik. Larutan Enzym yang dipakai adalah Helyzym / Alkazym yang berfungsi sebagai enzymatic cleaner, detergente enzimatico dan enzymatisch. Perendaman selama 10 - 15 menit.
 - h. Pembersihan / Pencucian

Tujuan utama pembersihan adalah menghilangkan kotoran terlihat, menghilangkan kotoran tidak terlihat dan menghilangkan sebanyak mungkin mikroorganisme berbahaya dengan memperhatikan aspek fundamental pembersihan. Pembersihan menggunakan sikat khusus instrumen.

Beberapa aspek fundamental proses pembersihan yang harus diketahui oleh staf CSSD adalah sebagai berikut:

1. Pada sterilisasi uap, bahan kemasan harus mudah kering dan memudahkan pengeringan isinya.
2. Pada sterilisasi panas-kering, bahan kemasan dan isinya harus tahan terhadap suhu selama waktu yang diperlukan, tanpa meleleh, terbakar, atau rusak.
3. Harus dapat menjaga sterilitas dan melindungi isinya yang sudah steril dari kontaminasi mikroba mulai saat kemasan dikeluarkan dari mesin sampai kemasan dibuka untuk dipakai. Karenanya, bahan yang dipakai sebaiknya tidak berbulu dan dapat menahan masuknya debu dan terserapnya uap (air atau cairan lainnya).

4. Harus cukup kuat menampung isinya selama proses sterilisasi dan penanganannya. Harus tahan sobekan dan tusukan, tidak boleh terpengaruh tingkat atmosfer dan kelembaban udara. Selama penyimpanan sebelum dan sesudah sterilisasi, bahan kemasan tidak boleh berkerut, berlubang jika dilipat, kusut atau melekat satu sama lain jika ditumpuk dan segel tidak boleh lepas.
5. Harus mudah digunakan untuk membungkus dan harus sesuai dengan ukuran dan bentuk alat yang akan dikemas dan harus membungkus alat rapat-rapat.
6. Tidak boleh mengandung bahan beracun dan zat warna yang bisa menyebabkan reaksi yang tidak diinginkan terhadap pekerja, atau yang luntur jika terkena sterilan.
7. Harus mudah dibuka dengan risiko kontaminasi kecil.
8. Bahan Pengemas yang digunakan disesuaikan dengan barang yang akan disterilkan serta metode sterilisasi.

NO	PENGEMAS	KETERANGAN
1.	Kain / Linen	a. Spesifikasi: Kain muslin atau sejenis, dengan pori pori 140 thread, non disposable. b. Metode kemasan : Amplop atau oblong, minimal 2 rangkap c. Metode sterilisasi : Dry Hit
2.	Kertas	a. Spesifikasi : tidak mudah rusak / robek selama proses, tidak toksis dan kedap air, sekali pakai (disposable). b. Metode kemasan : amplop atau kantong, minimal 2 rangkap. c. Metode sterilisasi : Dry Hit
3.	Kantong khusus / Pouches	a. Spesifikasi : Kantong terdiri dari 2 bagian yaitu sisi kertas dan plastik (rol dalam bentuk flat atau gussette) b. Pemakaian 1 kali atau <i>single use</i> c. Metode kemasan : kantong d. Metode sterilisasi : <i>Dry Hit</i>
4.	Bak Stainless-Steel	a. Spesifikasi : Bak instrumen : non disposable b. Metode kemasan : Tiap set dibungkus dengan kertas / linen c. Perkamen atau kain linen 2 rangkap d. Metode sterilisasi Dry hit

Tabel 4.1 Bahan Pengemas

Linen steril yang digunakan untuk kegiatan bedah di Instalasi kamar operasi :

Nama Linen	Keterangan	Jumlah
Linen Operasi	Sarung meja mayo	1
	Duk lubang besar	1
	Linen pembungkus (duk double)	1
	Linen kecil	4
	Linen double	1
	Handuk kecil	4
	Gaun	4
Linen mata	Duk lubang kecil	1
	Gaun	2

	Linen kecil	3
	Linen pembungkus	2

Tabel 4.2 Linen Steril pada Kegiatan Bedah

Cara membungkus peralatan medis menggunakan linen/ kertas Mebungkus dengan linen duk double sesuai ukuran / sesuai kebutuhan, dengan cara seperti membentuk amplop.

4.2 Tata laksana pelayanananan Proses Sterilisasi :

1. Penanggung jawab
Petugas Sterilisasi
2. Perangkat kerja
 - a. Peralatan medis
 - b. Kain tenun / Linen (baju operasi, duk tutup luka, dsbnya)
 - c. Alat labeling
 - d. Timbangan
 - e. Mesin Sterilisator

Sterilisasi adalah suatu proses untuk menghilangkan / memusnahkan semua bentuk mikroorganisme termasuk endospora pada peralatan, dapat dilakukan dengan proses fisika atau kimia dengan menggunakan alat Sterilisator.Metode yang digunakan di Rumah Sakit Prima husada adalah sterilisasi kering. Merupakan metode sterilisasi yang paling tua, namun aman dan murah. Metode ini menggunakan panas sebagai sterilan. Mekanisme pembunuhan mikroorganisme dilakukan menggunakan efek panas selama periode waktu tertentu.Metode ini hanya dapat digunakan untuk barang/alat yang stabil terhadap suhu tinggi.Mekanisme aksi sterilisasi panas adalah memaparkan panas tekanan tertentu selama waktu dan suhu tertentu pada suatu obyek sehingga terjadi pelepasan energi panas yang mengakibatkan pembunuhan mikroorganisme secara ireversibel akibat denaturasi atau koagulasi protein sel. Sterilisasi panas merupakan metode sterilisasi yang paling efektif karena panas merupakan pembawa energipanas paling efektif dan semua lapisan pelindung luar mikroorganisme dapat dilunakkan sehingga memungkinkan terjadinya koagulasi.

Pada tahun 1968 spaulding mengusulkan tiga kategori resiko berpotensi infeksi untuk menjadi dasar pemilihan praktek atau proses pencegahan yang akan di gunakan (seperti steriliusasi peralatan medis, sarung tangan dan perkakas lainnya) sewaktu merawat pasien. Kategori spaulding sebagai berikut;

1. *Kritikal*
Bahan dan praktek ini berkaitan dengan jaringan steril atau sistem darah sehingga merupakan resiko infeksi tingkat tinggi. Kegagalan manajemen sterilisasi dapat mengakibatkan infeksi serius dan fatal
2. *Semi kritisal*
Bahan dan praktek ini terpenting kedua setelah kritisal ,yang berkaitan dengan mukosa dan area kecil kulit yang lecet.pengelola perlu mengetahui dalam penanganan invasif pemrosesan desinfeksi tingkat tinggi (DTT), pemakaian sarung tangan bagi petugas yang menyentuh mukosa atau kulit tidak utuh
3. *Non kritisal*
Pengelolaan peralatan/bahan dan praktik yang berhubungan dengan kulit utuh yang merupakan resiko terendah. Walaupun demikian pengelolaan yang buruk akan dapat menghabiskan sumber daya dengan manfaaf yang terbatas (contoh sarung tangan steril di gunakan untuk memegang tempat sampah atau memindahkan sampah) .Di rumah sakit prima husada tidak dilakukan sterilisasi dari pihak luar. Dalam dekontaminasi perlatan pasien dilakukan

penatalaksanaan peralatan bekas pakai perawatan pasien yg terkontaminasi darah atau cairan tubuh (*precleaning, cleaning, desinfeksi dan sterilisasi*) sesuai standar prosedur operasional SPO sbg berikut :

- a. Rendam peralatan bekas pakai dalam air dan enzimatis ,lalu di bersihkan dengan sikat atau spons sebelum dilakukan DTT.
- b. Peralatanyang dipakai pasien infeksi harus di dekontaminasi dulu.
- c. Pastikan alat sekali pakai dibuang dan di musnahkan sesuai prinsip pembuangan sampah dan limbah yang benar,berlaku untuk alat yang dipakai berulang jika akan dibuang.
- d. Untuk alat bekas pakaiyang dipakai ulang setelah dibersihkan dengan spons atau sikat,di DTT dengan cairan enzimatis selama 15 menit.
- e. Peralatan non kritikal yang terkontaminasidapat di desinfeksi menggunakan alkohol 70 %,sedang untuk kritikal dan semi kritikal harus melalui pross desinfeksi dan sterilisasi.

BAB V

LOGISTIK

1. Prosedur permintaan dan pemakaian barang di CSSD dengan membuka catatan/arsip data tahun lalu dan tahun ini tentang permintaan dan pemakaian barang di CSSD. Hitung semua permintaan dan pemakaian tersebut tiap tahun.
2. Membuka arsip laporan kegiatan tahun lalu dan tahun ini. Menghubungkan dan mengelompokkan antara setiap kegiatan dengan mencatat dengan barang-barang biasa diperlukan untuk setiap kegiatan.
3. Membuka catatan tahun lalu dan tahun ini tentang kerusakan peralatan. Menghitung dan mencatat jumlah kerusakan dan pengantiannya.
4. Mengitung jumlah kelebihan barang tahun lalu dan tahun ini yang masih dapat dipakai untuk tahun yang akan datang.
5. Membuka data intensitas dan volume pelayanan sterilisasi tahun lalu dan tahun ini. menghitung peningkatan dan penurunan yang terjadi. Membandingkan peningkatan dan penurunan yang terjadi dengan pelayanan dua atau tiga tahun sebelumnya. Bila ada kecenderungan peningkatan, maka permintaan barang/bahan yang berhubungan dengan pelayanan sterilisasi harus ditambah. Bila sebaliknya, permintaan tetap.
6. Berdasarkan data-data diatas, dibuat rencana kebutuhan barang / bahan untuk tahun depan.
7. Menuliskan rencana kebutuhan tersebut dalam formulir yang telah disediakan menurut sumber pengadaannya.
8. Formulir tersebut diserahkan ke gudang terkait untuk ditindak lanjuti.

Peralatan yang ada di CSSD :

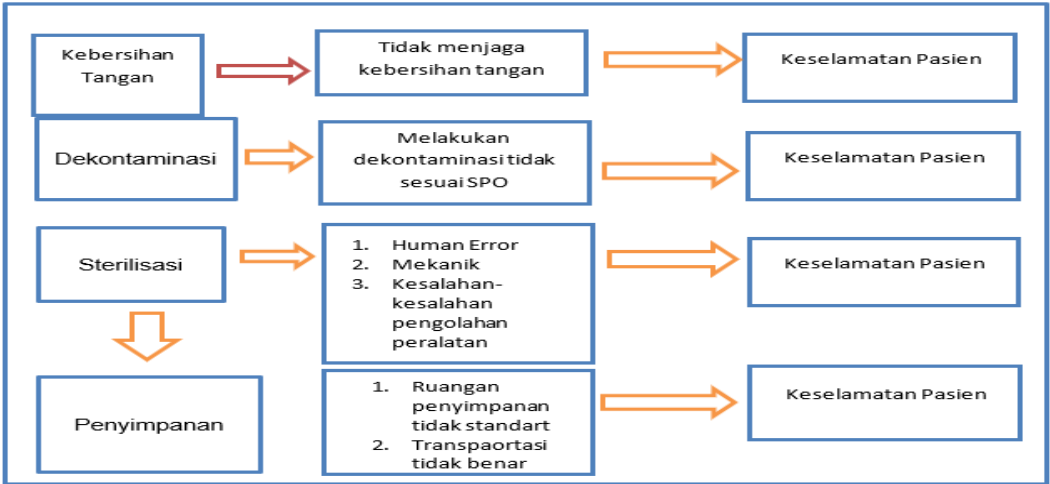
Tabel 5.1 Peralatan CSSD

No	Jenis	Jumlah
Peralatan Medis		
1	Sterilisator Merk ‘Memert’	1
2	Lemari rak linen bersi	1
3	Lemari rak alat steril	1
4.	Pengukur suhu	1
5.	Sealer	1
Peralatan Non Medis		
1	AC	1
2	Kursi	2
3	Meja	2
4	Telp	1
5	Box tertutup untuk cuci alat	2
6	Sikat	2
7	Sapu	1
Bahan Atau Zat kimia		
1	Indikator tape	Stok minimal 1 pcs
2.	Bowie dick test	Stok minimal 20 Lembar
3.	Alkacide	1 pack
4	Alkazime	1 Botol
5	Pouches berbagai ukuran	Stok Minimal 1 Rol
6	Label steril	Stok minimal 20
7	Kapas lidi, Kasa	Stok minimal 1 Rol
8	Pembersih lantai	Stok minimal 1
9	Spilkid	1

BAB VI

KESELAMATAN PASIEN DAN PETUGAS

- 6.1 Pengertian
- Di Unit Sterilisasi , keselamatan pasien lebih difokuskan pada tingkah laku petugas dan sterilitas alat, supaya tidak terjadi penularan dari alat kepada petugas ataupun pasien.
- 6.2 Tujuan
- Memenuhi standar keselamatan petugas kesehatan saat melakukan pengolahan alat melalui pemakaian APD yang benar dan proses sterilisasi yang sesuai standar.
- 6.3 Tata Laksana Keselamatan Pasien Dan Petugas Kesehatan Langkah-langkah penerapan keselamatan pasien rumah sakit:
1. Mulai dengan membuat standar prosedur operasional (SPO)
 2. Mencatat dan menuliskan laporan kejadian bila terjadi kejadian yang tidak diharapkan (KTD)
 3. Kepala Unit bersama pihak yang terkait melakukan penyelidikan terhadap KTD, mencari jalan keluar bila perlu merubah sistem sehingga lebih baik dan lebih aman untuk pasien, membuat tindak lanjut dan mensosialisasikan tindak lanjut untuk dilakukan bersama dan mengevaluasi sistem yang baru tersebut
 4. Melaporkan Indikator keselamatan pasien dan petugas kesehatan setiap bulan dalam rapat kerja bulanan dengan direksi.
 5. Pengurangan resiko infeksi dalam pelayanan kesehatan. Petugas CSSD bertanggung jawab terhadap pencegahan dan pengendalian infeksi pada pasien sehubungan dengan alat/instrumen yang digunakan.
 6. Setiap melakukan kegiatan di CSSD lakukan kebersihan tangan.
 7. Lakukan pengujian terhadap instrumen/alat sebelum didistribusikan.
 8. Pastikan bahwa semua barang telah didekontaminasi dan bebas dari kotoran, kerusakan atau bahaya lain yang dapat mempengaruhi penggunaan barang/alat.
 9. Pastikan bahwa barang terkontaminasi selalu dalam keadaan tertutup pada saat transportasi menuju ruang dekontaminasi.
 10. Pastikan semua peralatan yang digunakan untuk melakukan proses sterilisasi diuji secara teratur dan dijamin dengan baik.
 11. Pastikan bahwa semua komponen instrumen berada dalam keadaan lengkap dan berfungsi secara normal.



BAB VII

KESELAMATAN KERJA

7.1 Pengertian

Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah salah satu bentuk upaya untuk menciptakan tempat kerja yang aman , sehat, bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat mengurangi atau bebas dari kecelakaan kerjadan penyakit akibat kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan produktifitas kerja.

Penyakit Akibat Kerja (PAK) dan Kecelakaan Kerja (KK) dikalangan petugas kesehatan belum terekam dengan baik. Jika kita pelajari angka kecelakaan dan penyakit akibat kerja di beberapa negara maju dari beberapa pengamatan menunjukkan kecenderungan peningkatan prevalensi. Sebagai faktor penyebab adalah kurangnya kesadaran pekerja, serta kualitas ketrampilan pekerja yang kurang memadai , sehingga meremehkan resiko kerja, contohnya tidak menggunakan APD pada saat pengolahan alat steril.

7.2 Tujuan

Tujuan dari Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah supaya setiap pekerja di unit sterilisasi aman dari kecelakaan akibat kerja,termasuk aman dari paparan cairan tubuh yang infeksius dan zat-zat kimia lainnya.

7.3 Tata Laksana

1. Bangunan

Ruang Dekontaminasi	Ruang Penyimpanan
1. Udara harus dihisap (ada exhaust udara) ke luar gedung.	1. Penerangan harus memadai.
2. Ruangan Dekontaminasi menggunakan sistem tekanan negatif sehingga tidak akan mencemari ruangan lain.	2. Suhu antara 18oC – 22oC, dengan kelembaban antara 35 % -75 %
3. Tidak boleh menggunakan kipas angin.	3. Ventilasi menggunakan sistemn tekanan positif dengan efisiensi filtrasi partikulat berukuran 0,5 mikroen).
4. Suhu antara 18oC – 22oC, dengan kelembaban antara 35 % -75 %	4. Dinding dan lantai terbuat dari bahan halus dan kuat sehingga mudah dibersihkan.
5. Ruangan tidak boleh becek dan licin.	5. Letak rak penyimpanan barang steril 19-24 cm dari lantai dan minimal 43 cm dari langit- langit serta 5cm daridinding.
6. Lantai di bersihakn dan dipel minimal 1x sehari.	6. Harus diupayakan untuk menghindari penumpukan debu pada kemasan.
7. Bak pencuci, Meja kerja dan peralatan dibersihkan dan didisinfeksi minimal sekali sehari.	7. Barang steril tidak boleh disimpan dekat wastafel atau pipa pembuangan.
8. Apabila ada tumpahan darah langsung dibersihkan dan didisinfeksi menggunakan spiilkit	8. Akses ke ruangan penyimpanan steril dibatasi hanya kepada petugas yang terlatih, bebas dari penyakit menular dan menggunakan pakaian pelindung khusus.
9. Rak- rak penyimpanan, Dinding langit langit ventilasi AC dan alat lain dibersihkan secara teratur.	
10. Prosedur kontrol terhadap binatang perusak (Serangga, tikus dll)	
11. Sampah dibuang minimal 1x per shift atau sesuai kebutuhan jika penuh.	
12. Pemisahan sampah antara sampah infeksius, non infeksius dan sampah jarum.	

Tabel 7.1 Standar Bangunan

2. Alat Pengaman Diri.
 - a. Cuci tangan harus dijadikan budaya dalam setiap melakukan pekerjaan di Unit Sterilisasi
 - b. Penggunaan Alat Pelindung diri wajib dilakukan.
3. Monitoring Kesehatan
 - a. Monitoring Kesehatan pekerja Unit Sterilisasi dilakukan setiap 1 tahun sekali.
 - b. Bila terjadi luka tusuk, setiap pekerja wajib melakukan pemeriksaan dan pelaporan pajanan.
4. Keamanan Penerimaan Barang Kotor dan Area Dekontaminasi

Bahaya paparan terhadap darah dan cairan tubuh lainnya maupun zat kimia di lingkungan pusat sterilisasi dapat menyebabkan luka dan penyakit. Upaya pencegahan dapat dilakukan secara efektif dengan menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) untuk melindungi petugas dari kontaminasi. Petugas CSSD harus dilengkapi dengan alat pelindung diri seperti apron lengan panjang yang tahan terhadap cairan kimia, penutup kepala, masker dan kaca mata pelindung, khususnya untuk staf saat melakukan prosedur yang memungkinkan cipratan atau kontaminasi dari cairan yang mengandung darah atau cairan tubuh lainnya. Harus ada alas kaki khusus untuk memasuki ruang dekontaminasi dan sepatu tahan air. Masker dan kaca mata pelindung harus dilepas saat meninggalkan ruang dekontaminasi. Sarung tangan, gaun pelindung dan kaca mata pelindung harus dicuci setiap hari. Alat pelindung yang dipakai ulang harus dicuci setelah setiap pemakaian. Penanganan yang salah terhadap alat-alat tajam terkontaminasi seperti pisau, jarum dan yang lainnya dapat menyebabkan rusaknya permukaan kulit yang pada akhirnya dapat memungkinkan masuknya mikroorganisme patogen ke dalam tubuh sehingga menyebabkan terjadinya penyakit.

Saran Tindakan aman:

- a. Jangan sekali-kali memasukkan tangan ke dalam wadah berisi barang terkontaminasi tanpa dapat melihat secara jelas isi dari wadah tadi.
 - b. Tuangkan cairan yang dapat mengganggu pandangan terhadap alat-alat, lalu pindahkan alat / instrumen satu per satu. Pada saat transportasi, pastikan agar bagian runcing dari instrumen mengarah berlawanan terhadap tubuh kita.
 - c. Buang sampah benda tajam (jarum suntik, silet) ke dalam wadah tahan tusukan, jangan pada tempat sampah biasa.
 - d. Ikuti petunjuk pabrik mengenai penggunaan zat kimia secara aman dan gunakan alat pelindung diri untuk mencegah paparan zat kimia terhadap kulit dan membrana mukosa (selaput lendir) yang dapat menyebabkan luka bakar kimia.
 - e. Berhati-hatilah apabila mendekati area yang berair (area dekontaminasi dan pencucian), pastikan lantai tidak licin.
 - f. Pada waktu mencuci instrumen di dalam bak, gosoklah instrumen di bawah permukaan air untuk mencegah terjadinya aerosol yang dapat terhirup.
5. Keamanan Proses Sterilisasi

Pengoperasian mesin sterilisasi hanya boleh dilakukan oleh petugas terlatih yang telah mendapat pelatihan tentang prinsip dasar sterilisasi dan cara menggunakan mesin sterilisasi yang benar, sehingga kemungkinan

terjadinya kecelakaan kerja dapat diperkecil dan upaya penyediaan barang steril lebih terjamin. Jenis luka yang dapat terjadi di daerah ini meliputi luka bakar pada kulit maupun selaput lendir yang disebabkan oleh kelalaian pada penggunaan zat kimia maupun akibat terlalu dekatnya posisi terhadap sumber panas (misalnya sterilisator uap, sterilisator panas kering). Selain itu juga dapat terjadi luka pada mata akibat cipratan zat kimia, sehingga diperlukan alat pelindung mata.

Saran Tindakan aman:

- a. Gunakan sarung tangan tahan panas pada saat menangani obyek bersuhu tinggi.
- b. Hati-hati pada saat menggunakan “sealer panas” dan pemotong kantong sterilisasi (pouches).
- c. Pengoperasian mesin sterilisasi hanya boleh dilakukan oleh petugas terlatih.

6. Penanganan zat kimia di CSSD

Mengingat banyak zat kimia yang digunakan di CSSD bersifat toksik, maka penanganan zat kimia di CSSD sangat perlu diperhatikan. Hal ini penting, karena apabila tidak ditangani secara baik dapat membahayakan baik bagi petugas maupun pasien. Adapun penanganan zat zat kimia tersebut terpapar lengkap di MSDS (Master Safety Data Seet).

BAB VIII

PENGENDALIAN MUTU

Tujuan pelayanan sterilisasi adalah untuk menyediakan produk steril, namun bukan berarti sekedar menghasilkan barang yang steril. Harus ada jaminan bahwa barang yang telah disterilkan benar-benar steril. Oleh karenanya harus dilakukan monitor proses sterilisasi untuk memberi jaminan bahwa parameter yang ditentukan dalam proses sterilisasi sudah dipenuhi dengan baik. Selain itu, juga harus dilakukan evaluasi mutu hasil sterilisasi untuk mengetahui apakah barang/alat yang disterilkan sudah betul-betul steril. Beberapa halberkaitan dengan proses sterilisasi Dry hit yang perlu dipantau antara lain:

- a. Uji kebocoran (leak rate test),
- b. Uji pengosongan udara (tes Bowie-Dick)
- c. Pencatatan suhu (thermograph),

8.1 Kontrol Kualitas Sterilisasi

Kontrol proses sterilisasi yang ketat akan memberikan jaminan bawa peralatan medis yang kita sediakan adalah benar-benar steril Caranya adalah dengan melakukan kultur atau uji sterilitas dari setiap produk yang disterilkan. Tapi cara ini sangat tidak praktis dan juga mahal, maka sebagai jalan keluar kita perlu melakukan apa yang disebut sebagai Monitoring Proses Sterilisasi, yatu memonitor proses sterilisasi yang kita lakukan untuk memberikan jaminan bahwa parameter-parameteryang ditentukan dalam proses sterilisasi sudah baik.

Hal- hal yang perlu diperhatikan dalam kontrol kualitas :

- 1. Pemberian nomor lot pada setiap kemasan. Setiap kemasan yang disterilkan harus mencantumkan identitas berupa nomot lot yang mencakup : nomormesin sterilisasi, Tanggal proses sterilisasi dan keterangan siklus ke berapa dari mesin sterilsasi.
Alasan : Identifikasi ini akan memudahkan pada saat diperlukan melakukan recall atau penarikan kembali kemasan yang sudah didistribusikan.
- 2. Data mesin Sterilisasi Untuk setiap siklus sterilisasi yang dilakukan harus didokumentasikan :
 - a. Nomor lot
 - b. Informasiumum kemasan (linen, instrumen)
 - c. Waktu pemaparan dan suhu (kalau belum tercatat oleh mesin sterilisasi)
 - d. Nama Operator
 - e. Data hasil uji Bowie-Dick
- 3. Waktu Kadaluarsa Setiap kemasan steril yang akan digunakan harus diberi label yang mengindikasikan waktu kadaluarsa untuk memudahkan rotasi stok Batas kadaluarsa produk hasil steril:

Kadaluarsa	Cara Sterilisasi dengan bahan pengemas
Satu minggu	Sterilisasi dengan dry hit bungkus menggunakan kertas atau linen rangkap
Satu Bulan	Sterilisasi dengan dry hit dengan pouches menggunakan suhu 160'C selama 2 jam, dalam kemasan pouches
Satu minggu	Sterilisasi dengan dry hit dengan pouces menggunakan suhu 105'C dalam 1 jam dalam kemasan pouches

Tabel 8.1 Batas Kadaluarsa Produk Hasil Steril

8.2 Monitoring Proses Sterilisasi

Monitoring proses sterilisasi dilakukan dengan menggunakan indikator sterilisasi. Jenis-jenis Indikator Sterilisasi:

1. Indikator Mekanik

Indikator mekanik adalah bagian dari instrumen mesin sterilisasi seperti gauge, tebal, dan indikator suhu maupun tekanan yang menunjukkan apakah alat sterilisasi bekerja dengan baik. Pengukuran suhu dan tekanan merupakan fungsi penting dari sistem monitoring. Bila indikator mekanik berfungsi dengan baik, akan memberikan informasi segera mengenai suhu, tekanan, waktu dan fungsi mekanik lain dari alat. Karena bersifat mekanis, maka bila tidak dilakukan kalibrasi alat dengan tepat atau pemakaian yang terlalu sering dapat memberikan informasi yang tidak tepat.

2. Indikator kimia

Adalah indikator yang menandai terjadinya paparan sterilisasi pada obyek yang disterilkan yang ditandai dengan adanya perubahan warna. Indikator kimia diproduksi dalam berbagai bentuk (strip, tape, kartu, vial). Yang dipakai di CSSD berupa tape. Indikator ini memberikan informasi kondisi steril pada tiap kemasan (pack by pack basis), sehingga selain digunakan di luar, ada juga yang diletakkan di dalam kemasan.

Klasifikasi indikator kimia:

a. Kelas 1: indikator eksternal dan indikator internal

Indikator eksternal, contoh: Autoclave tape berbentuk tape (pita), dan digunakan di bagian luar setiap kemasan. Dengan terjadinya perubahan warna, indikator ini memberi informasi:

- Bahwa bagian luar kemasan telah melewati proses sterilisasi.
- Membedakan antara benda yang sudah dan belum disterilkan, dan
- Berfungsi sebagai segel/pengaman kemasan.

Indikator internal, contoh:

- Comply

(3M) Indikator ini berbentuk strip dan pemakaiannya diletakkan dalam tiap kemasan. Melalui perubahan warna yang terjadi, indikator ini memberi informasi bahwa benda dalam kemasan telah melewati proses sterilisasi, yang berarti pula sterilan telah berpenetrasi ke dalam kemasan.

- Bowie-dick Test

Indikator ini digunakan untuk menilai efisiensi pompa vakum pada alat sterilisasi, serta untuk mengetahui adanya kebocoran udara dalam ruang sterilisasi. Indikator ini hanya digunakan pada metode sterilisasi uap panas yang menggunakan sistem vakum. Bila alat sterilisasi sudah dilengkapi dengan perangkat untuk menguji kebocoran udara, maka tidak perlu lagi dilakukan tes Bowie-Dick. Tes Bowie-Dick dilakukan dengan Bowie-Dick dengan kemasan kertas dan dalam kemasan tabung. Lembar tes Bowie-dick diletakkan di tengah-tengah kemasan. Kemasan uji dimasukkan dalam sterilisator yang kosong, tepatnya di bagian depan bawah, di atas drain. Kemudian dilakukan sterilisasi pada suhu 132°C-134°C selama 3,5 - 4 menit (perhitungan waktu mulai dilakukan saat suhu menunjukkan 132°C). Setelah selesai, lembaran tes dievaluasi. Hasil yang baik ditandai dengan perubahan warna dari putih menjadi hitam merata. Bila warna tidak merata, maka diduga masih ada udara yang tertinggal dalam ruang sterilisasi yang berarti kerusakan pompa vakum dari alat. Dilakukan setiap hari Senin dan Kamis

b. Kelas 2 (Indikator single parameter)

c. Kelas 3 (Indikator multiparameter)

- d. Kelas 4 (Integrator)
 - e. Kelas 5 (Emulgator) tidak dilakukan di CSSD Rumah Sakit Prima Husada karena tidak direkomendasikan oleh berbagai organisasi (AAMI, AORN, CDC, JC) sebagai bagian dari program jaminan sterilitas.
3. Indikator Biologi
- Adalah sediaan berisi populasi mikroorganisme spesifik dalam bentuk spora yang bersifat resisten terhadap beberapa parameter yang terkontrol dan terukur dalam suatu proses sterilisasi tertentu. Prinsip kerja dari indikator biologi adalah dengan mensterilkan spora hidup yang non patogenik dan sangat resisten dalam jumlah tertentu. Apabila selama proses sterilisasi spora tersebut terbunuh, maka diasumsikan bahwa mikroorganisme lainnya juga ikut terbunuh dan benda yang disterilkan bisa disebut steril. Indikator biologi tersedia untuk metode sterilisasi uap panas, gas etilen oksid dan panas kering. Indikator biologi yang digunakan adalah ampul Attest. Ampul dimasukkan pada bagian tengah kemasan uji (menggunakan handuk khusus (28 - 32 lembar) yang dilipat menjadi tiga bagian. Handuk tersebut disusun sedemikian rupa sehingga berukuran 12 x 9 inchi dan tingginya 10 -11 inchi) . Kemasan uji tersebut diletakkan pada bagian depan bawah di atas drain, bersama barang lain yang akan disterilkan. Lakukan sterilisasi sesuai suhu yang diinginkan. Setelah sterilisasi selesai, indikator diaktifkan (ampul dipecah), kemudian dimasukkan dalam inkubator (suhu 57oC selama 24-48 jam). Bila selama proses sterilisasi spora terbunuh, maka tidak akan terjadi perubahan warna (tetap berwarna ungu). Ini berarti proses sterilisasi telah tercapai. Sebaliknya bila spora dapat bertahan maka dalam media pertumbuhan akan terjadi pembentukan asam yang dapat mengakibatkan perubahan warna.

8.3 Monitoring Mutu Hasil Sterilisasi

1. Uji sterilitas dengan cara uji swab
Di Rumah Sakit Prima Husada monitoring mutu hasil sterilisasi dilakukan dengan cara swab yang dilakukan tiap 6 bulan sekali. Bahan uji meliputi instrumen, kassa, kapas lidi, kain tenun, dan selang yang telah disterilkan. Bahan tersebut dikirim ke laboratorium mikrobiologi. Apabila kualitas hasil sterilisasi dikatakan baik. Hasil swab dilaporkan kepada direktur.
2. Surveilans kejadian infeksi luka operasi
Salah satu dampak terpenting akibat mutu hasil sterilisasi yang kurang baik adalah terjadinya infeksi luka operasi, oleh karena itu salah satu cara memonitor mutu hasil sterilisasi adalah dengan memantau terjadinya kasus infeksi luka operasi. Pemantauan dilakukan setiap hari pada semua pasien paska operasi, Pemantauan dillakuan dengan pelaporan temuan perawat poli bedah. Yang dipantau adalah ada/tidaknya gejala/tanda infeksi luka operasi sesuai kriteria diagnosis infeksi luka operasi dilakukan oleh KPPI.

8.4 Monitoring Mutu Air Bersih

Untuk mengetahui mutu air bersih yang digunakan di CSSD, dilakukan pemeriksaan mutu air bersih tiap 1 bulan sekali untuk pemeriksaan Mikrobiologi dan Fisika serta 6 bulan sekali untuk pemeriksaan Kimia air bersih. Sampel diambil dari tandon utama air yang digunakan untuk pemakaian CSSD, pengambilan dilakukan oleh petugas pengelola air bersih dari Bagian Sanitasi. Selanjutnya sampel dikirim ke Laboratorium untuk diperiksa apakah memenuhi syarat mutu air bersih/tidak. Bila hasil belum baik, maka dilakukan tindak lanjut berupa pengurasan bak penampung dan pembubuhan kaporit sesuai prosedur. Hasil monitoring mutu air bersih RS Prima Husada adalah baik.

BAB IX

PENUTUP

Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menjadi tantangan yang harus diantisipasi para praktisi pelayanan kesehatan. Selain itu kita juga dituntut memberikan pelayanan yang profesional dengan diberlakukannya undang-undang tentang Praktek Kedokteran yang ditujukan bagi kepastian hukum baik bagi penerima pelayanan maupun pemberi pelayanan kesehatan.

Kejadian infeksi di rumah sakit adalah infeksi yang didapat atau timbul pada waktu pasien dirawat di rumah sakit. Bagi pasien di rumah sakit infeksi di rumah sakit merupakan persoalan serius yang dapat menjadi penyebab langsung maupun tidak langsung kematian pasien. Beberapa kejadian infeksi di rumah sakit mungkin tidak menyebabkan kematian pasien namun menyebabkan pasien dirawat lebih lama di rumah sakit ini berarti pasien membayar lebih mahal. Pencegahan dan Pengendalian infeksi di rumah sakit (PPIRS) merupakan kegiatan yang sangat penting dan salah satu faktor yang mendukung untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan erat kaitannya dengan citra rumah sakit. Oleh karena itu pencegahan dan pengendalian infeksi perlu diperhatikan. Salah satu upaya untuk menekan kejadian infeksi nosokomial adalah dengan melaksanakan pelayanan Pusat Sterilisasi (Central Sterile Supply Department (CSSD) yang baik.

Tanggung jawab untuk melaksanakan semua kegiatan secara aman di lingkungan pusat sterilisasi menjadi tanggung jawab petugas pusat sterilisasi. Setelah dilakukan pembekalan terhadap petugas terhadap bahaya yang mungkin terjadi di lingkungan pusat sterilisasi. Pada dasarnya kecelakaan dapat dihindari dengan mengetahui potensi bahaya yang dapat ditimbulkan. Dengan memperhatikan secara seksama dan melatih teknik- teknik bekerja secara aman maka resiko terjadinya kecelakaan kerja dapat diturunkan secara signifikan.

Penyusunan pedoman pelayanan unit sterilisasi ini adalah merupakan langkah awal sebagai suatu proses yang panjang sehingga memerlukan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak dalam penerapannya untuk mencapai tujuan unit sterilisasi dan tujuan rumah sakit dalam memberikan pelayanan sampai paripurna.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 4 Juni 2025
Direktur Rumah Sakit Prima
Husada,

dr. Nur Mazidah